

Aquablation (Операция на простате с помощью водяной струи)

WARWIKI

Информация для пациента · Лечение увеличенной простаты без теплового воздействия под контролем УЗИ

Aquablation — это современный метод хирургического лечения доброкачественной гиперплазии простаты (ВРН): **высокоточная водяная струя под высоким давлением без теплового воздействия**, вводимая через уретру под контролем ультразвука, удаляет ткань, препятствующую мочеиспусканию. Метод направлен на устранение обструкции при лучшем сохранении половой функции — в исследованиях ретроградная эякуляция возникала **реже, чем при TURP**.

Об этой процедуре

Используя эндоскоп и изображение простаты в режиме реального времени (**УЗИ**), хирург точно определяет, какую ткань нужно удалить. Затем **водяная струя под роботизированным управлением** удаляет эту ткань без нагрева. Кратковременная коагуляция останавливает кровотечение, после чего устанавливается катетер.

Преимущества Aquablation

- **Точный контроль под УЗИ**; подходит для простаты разного размера, включая крупные железы
- Улучшение мочеиспускания **сопоставимо с TURP**
- Лучшее **сохранение эякуляции** по сравнению с TURP

Это относительно новый метод; данные долгосрочного наблюдения продолжают накапливаться.

ТЕРМИНЫ

Aquablation

Удаление ткани простаты при ВРН с помощью водяной струи.

ВРН

Доброкачественное (не онкологическое) увеличение простаты.

Без теплового воздействия

Ткань удаляется давлением воды, а не теплом.

Под контролем УЗИ

Изображение в реальном времени позволяет точно спланировать лечение.

Ретроградная эякуляция

«Сухой оргазм» — после Aquablation возникает реже, чем при TURP.

Катетер

Трубка для дренирования мочевого пузыря на один-два дня после операции.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ TURP? Aquablation удаляет ткань простаты **точной водяной струёй без нагрева под контролем УЗИ**, а не электрической петлёй. Результаты мочеиспускания сопоставимы с TURP, однако **эякуляция сохраняется лучше**. Среди особенностей: метод более новый с меньшим объёмом долгосрочных данных, кровотечение контролируется кратким этапом коагуляции.

Как подготовиться

- Операция проводится под **общей или спинальной анестезией** — соблюдайте предписания по голоданию и приёму лекарств (разжижители крови отменяют по указанию врача).
- **Анализ мочи** для исключения инфекции.
- Организуйте сопровождение; рассчитывайте на короткое время с катетером.

Что происходит и что будет после

- 1 Вас усыпят или обезболят; вводят антибиотики.
- 2 УЗИ картирует простату, хирург планирует зону воздействия.
- 3 Водяная струя удаляет ткань; кратко выполняется коагуляция для остановки кровотечения.
- 4 Устанавливают катетер, который обычно удаляют примерно через **1–2 дня**; как правило, одна ночь в стационаре.

В течение нескольких недель ожидайте **примесь крови в моче** и жжение/позывы; пейте больше жидкости, избегайте натуживания и тяжёлых нагрузок.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- После удаления катетера **нет мочеиспускания**
- **Сильное кровотечение или сгустки**, затрудняющие мочеиспускание
- Жар или озноб
- Кровотечение усиливается, а не уменьшается

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Aquablation удаляет обструктивную ткань простаты точной водяной струёй без нагрева под контролем УЗИ через уретру.
2. Результаты мочеиспускания сопоставимы с TURP, при этом **эякуляция сохраняется лучше**; метод новый, долгосрочные данные продолжают накапливаться.
3. Катетер удаляют быстро. При невозможности помочиться, сильном кровотечении или жаре — обратитесь к врачу.